

QCM Psychiatrie

Q1 : 40 ans, connu pour un trouble bipolaire sans traitement consulte pour un état dépressif d'intensité relativement sévère avec tristesse, perte de plaisir, trouble du sommeil, sentiment de désespoir et de dévalorisation. Il présente quelques idées suicidaires mais mentionne ne pas vouloir passer à l'acte. Tests hépatiques perturbés. Reste sp. TT médicamenteux :

- A. Carbamazépine
- B. Halopéridol
- C. Lithium
- D. Diazépam
- E. Sertraline

R : C

Lithium est éliminé par voie rénale (donc pas de pb ici avec les tests hépatiques perturbés)

Traitement pour trouble bipolaire type 1 et 2 :

- Première intention : lithium, lamotrigine, quétiapine, olanzapine + ISRS (NB : attention ISRS seuls risquent de déclencher une phase maniaque)
- Deuxième intention : valproate, lurasidone

Quel que soit la phase du trouble bipolaire (humeur haute ou basse)

Q2 : Patiente de 20 ans, crises de colère qu'elle ne peut maîtriser surtout avec petit copain. Craint constamment qu'il ne la quitte et se sent particulièrement mal. Elle se cogne la tête contre les murs pour soulager sa détresse. Elle a ce genre de comportement depuis l'adolescence, dit ne pas savoir qui elle est vraiment. Souffre beaucoup et pense souvent à la mort, dit ne pas être triste et prend du plaisir à dessiner par exemple. Diagn :

- A. Trouble de la personnalité borderline
- B. Trouble bipolaire de type 2
- C. Trouble bipolaire type 1
- D. Trouble dépressif récurrent
- E. SCZ

R : A

Peur de l'abandon, comportement auto-dommageable.

Q3 : 54 ans, trouble bipolaire, se présente pour rdv de suivi. Ne se sent pas triste, dit être souvent fatiguée et avoir froid. Prise 13kg en 6 mois. Elle essaie de faire de l'exercice, de manger sainement et prend son traitement de lithium. TA 110/80, FC 65/min. Un peu ralentie psychiquement, reste sp. Prochaine étape :

- A. Prescrire du citalopram
- B. Prescrire du méthylphénidate
- C. Faire des tests thyroïdiens
- D. Débuter une luminothérapie
- E. Faire un test d'effort

R : C

Ca peut être une dépression mais il faut d'abord exclure l'hypothyroïdie.

Q4 : Femme de 31 ans, se sent plus déprimée chaque automne, fatiguée, et moins d'intérêt à faire certaines activités qui lui plaisent habituellement. Dort plus et est somnolente toute la journée. Prend 10kg pendant l'hiver. Ces symptômes se résolvent spontanément au printemps.

PEC ?

- A. Thérapie basée sur la pleine conscience
- B. Neurofeedback
- C. Cimplément vitaminiques (B12, B6, C et E)
- D. Hormones thyroïdiennes
- E. Luminothérapie

R : E

Q5 : 45 ans, connu pour trouble dépressif récurrent traité par le passé avec succès par de la sertraline, se présente pour un nouvel épisode dépressif d'intensité moy. Il est d'accord de reprendre un tt pour autant que ce dernier n'induisse pas de pb de libido et d'érection.

- A. Proposer du bupropion (inhibiteur de la recapture de la DA, pas d'action sur la sérotonine)
- B. Prescrire l'ATD qui avait marché par le passé (sertraline)
- C. Proposer de la paroxétine
- D. L'informer qu'il n'existe pas d'ATD sans effet sur la libido ou l'érection
- E. Proposer de la venlafaxine

R : A

Paroxétine et sertraline = SSRI (donc on va avoir un effet sur la libido).

Venlafaxine = inhibiteur de la NA et de la sérotonine (aussi effet sur libido via sérotonine)

ATD Tricyclique : agissent aussi sur la sérotonine

Donc bupropion ou new générations

Q6 : Homme de 43 ans, sans atcd connu, se présente car depuis 3 mois il présente des épisodes subits de palpitations, dyspnée, sensation de claustrophobie, et paresthésies distales. Il paraît calme mais affirme que plus tôt il fait une attaque. TA 150/110, FC 105/min.

Patient transpirant, pupilles dilatées. Analyses urinaires reviennent + pour la cocaïne.

Prochaine étape :

- A. Prescrire du lorazepam et un rdv de suivi chez le MT
- B. Donner une prescription de paroxétine (= SSRI) et un rdv de suivi chez psy
- C. Thérapie par agoniste pour sa dépendance à la cocaïne
- D. TCC et exercices de relaxation
- E. Le référer à un collègue pour le traitement de sa dépendance à la cocaïne

R : E

On peut aussi donner un peu de lorazepam en attendant mais il faut rdv chez spécialiste et pas MT.

Si conso de cocaïne fumée (en crack ?), dépendance +++, on peut donner de la méthadone. Parfois on donne aussi des agonistes de la DA, toujours en association avec une psychothérapie.

Q7 : 44 ans, HIV +, dépendant à l'héroïne, amené pour délire parano que son proprio tente de l'empoisonner. Le patient n'est pas agité, n'exprime pas d'idéation suicidaire ou meurtrière, et n'a pas de plainte d'ordre dépressif. Première fois qu'il délire. Examen psychique sp, analyses toxique, FSC, chimie sanguine, PL et CT avec injection sp. Admis en psychiatrie avec DD de trouble psychotique non spécifique vs psychose secondaire à l'infection VIH. TT :

- A. Amitriptyline 200 mg au coucher (ATD tricyclique)
- B. Diazepam 10 mg 4x/j

- C. Trazodone 100 mg 3x/j (SSRI ?)
- D. Méthylphénidate 5mg 1x/j
- E. Olanzapine 5mg 2x/j

R : E

Q8 : H de 45 ans, admis en raison de changement ECG après prise de cocaïne. Pas de signes de confusion, orienté dans tous les modes, n'a pas d'anxiété ou de dépression. 2^e jour : ECG normal, IM exclu. Il dit qu'il se sent très déprimé et fatigué, qu'il a de la peine à bouger, nie toute idéation suicidaire ni sensation de culpabilité, ni paranoïa, ni troubles perceptifs. PV stables.

Prochaine étape :

- A. Administrer de l'halopéridol pour traitement les symptômes psy et physiologiques du sevrage
- B. Observer ses symptômes jusqu'à résolution du sevrage
- C. Effectuer des tests neuropsychologiques pour évaluer présence d'un trouble bipolaire
- D. Thérapie électro convulsive
- E. Psychothérapie

R : B

Sevrage de la cocaïne fait un syndrome pyramidal donc l'halopéridol va encore empirer.

Q9 : 56 ans, dépendance OH, souhaite quitter l'hôpital contre avis médical. Admis 13j auparavant en raison d'une hémorragie sur ulcère gastrique et pneumonie d'aspiration. Médicalement stable pour sortir, mais l'équipe médicale est à la recherche d'un placement dans une unité ambulatoire de traitement de la dépendance à l'OH. Le patient affirme qu'il ne souhaite pas un tel traitement, dit qu'il n'est pas déprimé ni suicidaire. Pas d'hallucinations ni de délire.

R : Permettre au patient de sortir contre avis médical et l'aiguiller vers un programme ambulatoire de traitement de sa dépendance à l'OH

Autres :

- Permettre au patient d'être libéré à la condition qu'il soit emmené et interné dans un centre de désintoxication alcoolique
- Obtenir une décision psychiatrique qui statue que le patient doit laisser l'hôpital le soigner et prendre des décisions de placement
- Effectuer une contention physique puis réévaluer le patient
- Mettre le patient sous tutelle en raison de son trouble du jugement

Q10 : 31 ans, épisode maniaque aigu. Il est menaçant, nécessite injection IM d'halopéridol. Après une semaine d'hospitalisation, son agitation est contrôlée, il ne présente plus que des symptômes d'hypomanie. Déjà été hospitalisé 3x par le passé pour des épisodes maniaques. Lors d'un coloc, ses traitements d'halopéridol et de lithium sont discutés. Si le patient est laissé sous halopéridol avec sa maladie bipolaire, il serait exposé à un risque accru de :

R : dyskinésies

NB Agranulocytose —> olanzapine

Q11 : Gary est un jeune de 19 ans qui s'est retiré de l'université après avoir eu des troubles du comportement au cours duquel la police a dû intervenir. En effet, il avait enclenché toutes les alarmes incendies du campus, pour voir si elles marchaient bien. Ces derniers temps, il avait changé d'orientation universitaire de l'ingénierie à la philosophie et avait de plus en plus réduit son temps de sommeil, passant de longues heures à parler avec ses

amis de la nature de la réalité. Il était convaincu de l'importance de ses idées, affirment fréquemment qu'il était plus savant et avancé que tous ses professeurs. Il a dit aux autres qu'il était sur le point de révolutionner son domaine et il est devenu de plus en plus irritable et intolérant envers tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il a des relations sexuelles multiples et non protégées.

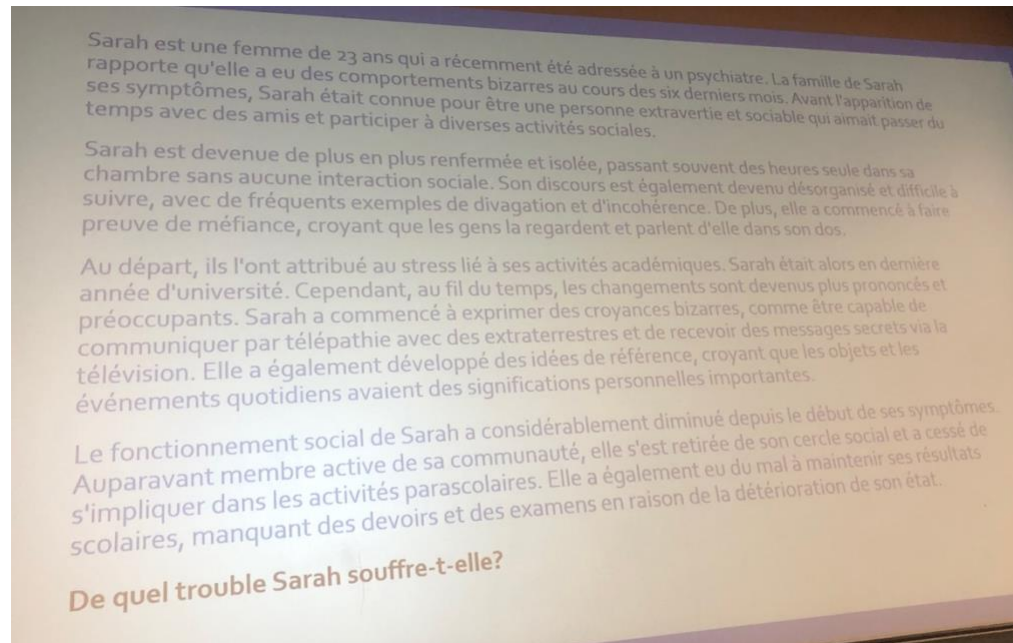
Les parents de Gary sont choqués par son attitude et ne le reconnaissent pas. Il a eu des problèmes d'anxiété et de dépression dans son adolescence. Diagn :

R : Trouble bipolaire type 1

Q12 : photo, 23 ans. Diagn :

R : Schizophrénie

- Délire de persécution, mystique, de référence
- Hallucinations
- Prodrome : symptôme nef, retrait social...



Q13 : Catherine est une femme de 28 ans qui souffre d'une détresse et d'un handicap important en raison de sa peur des situations où elle doit rencontrer des gens. Elle évite les interactions sociales autant que possible et se sent extrêmement anxieuse et gênée lorsqu'elle est au centre de l'attention. Elle s'inquiète excessivement d'être gênée ou humiliée devant les autres. Elle a limité ses opportunités de carrière et a peu de relations proches. Ces symptômes persistent depuis au moins 6 mois et n'expliquent pas mieux par un autre problème de santé mentale. Diagn :

R : Anxiété/phobie sociale

≠ Anxiété généralisée : crainte démesurée par rapport aux événements quotidiens de la vie, sans raison apparente. Ex : peur de perdre son travail, de perdre son permis...

Q15 : Quel est le symptôme central d'un trouble de la personnalité borderline ?

- A. SCZ
- B. Peur excessive des situations sociales
- C. Instabilité émotionnelle et des relations interpersonnelles
- D. Obsessions et compulsions récurrents

R : C

Q16 : Parmi ces affirmations concernant le PTSD, laquelle est juste ?

- A. Peut survenir en l'absence d'un événement traumatique
- B. N'arrive que chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques prémorbides

- C. Seul l'événement traumatique lui-même permet de prédire le risque de PTSD
- D. Ne fait pas toujours suite à un état de stress aigu
- E. Le risque de PTSD diminue en cas de dissociation péri-traumatique

R : D

PTSD complexe, peut survenir longtemps après des expositions répétées.

Q17 : Laquelle de ces propositions est juste concernant les TOC :

- A. Traitement de 1^{er} ligne = antipsychotiques atypiques
- B. Obsession = pensée, images ou pulsions
- C. L'approche psychothérapeutique de choix est la thérapie systémique
- D. Age médian d'apparition : 35 ans
- E. Critère diagn : durée > 5h/j

R : B

TT de 1^{er} intention : SSRI, ATC, psychothérapie TCC.

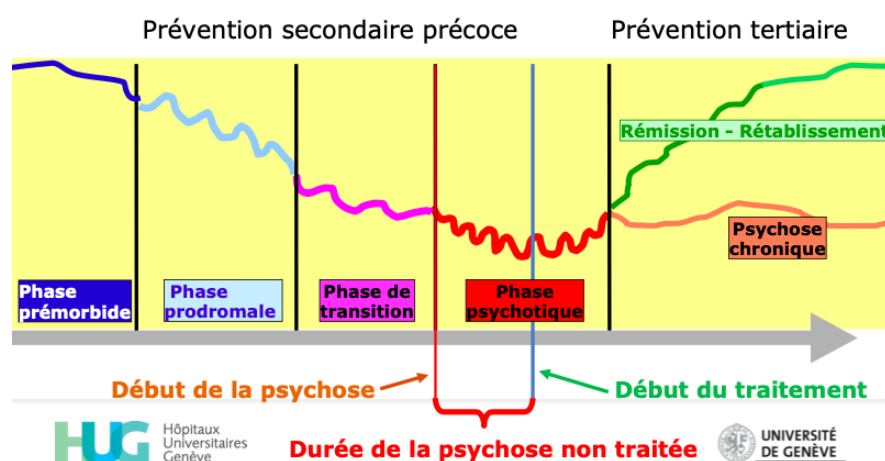
Age médian : 19 ans

Durée : >1h/j

Q19 : Concernant la cinétique d'évolution de la SCZ :

- A. Lors de la phase prodromique on retrouve habituellement déjà des symptômes de type hallucinations auditives ou visuelles
- B. La phase prodromique est plutôt rare dans l'émergence de la SCZ
- C. La phase prodromique marque souvent le début d'un isolement social et un désinvestissement de la vie scolaire
- D. La durée de la psychose non traitée n'a pas d'impact sur le pronostic d'évolution de la SCZ
- E. La prévention secondaire précoce commence lors du diagnostic de premier épisode psychotique

R : C



Q20 : Laquelle de ces propositions n'est pas un symptôme psychotique neg ?

- A. Aboulie
- B. Anhédonie
- C. Anosognosie
- D. Émoussement affectif
- E. Retrait social

R : C

Anosognosie est souvent présent dans la SCZ, mais c'est pas un symptômes neg.

Q21 : Laquelle de ces propositions est vraie concernant le diagnostic de SCZ selon DSM-5 ?

- A. Au moins 2 symptômes pendant un mois, dont au moins un des 3 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, symptômes négatifs, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique
- B. “ dont au moins un des 3 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique, symptômes neg
- C. Au moins 2 symptômes pendant 6 mois, dont au moins un des 3 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, symptômes neg, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique
- D. Au moins 2 symptômes pendant 6 mois dont au moins un des 3 premiers symptômes : idées délirantes, hallucinations, discours désorganisé, comportement désorganisé ou catatonique, symptômes neg
- E. Au moins 3 symptômes blabalbla non pas 3

R : B

6 mois c'est pour les symptômes neg.

Q22 : Lequel de ces symptômes est indispensable pour poser un diagn de trouble dépressif :

- A. Diminution du plaisir
- B. Troubles du sommeil
- C. Ralentissement psychomoteur
- D. Sentiment de dévalorisation
- E. Troubles de la concentration

R : A

Q23 : laquelle de ces affirmations est juste concernant le tt des épisodes dépressifs :

- A. En cas de non-réponse au tt ATD, la première alternative est l'ajout d'un second ATD de classe différente (non, on change d'ATD... ?)
- B. Les antipsychotiques typiques sont reconnus comme tt d'augmentation des tt ATD (non c'est les atypiques)
- C. La psychothérapie n'est pas indiquée comme tt de la dépression sévère
- D. LA TMS (stimulation magn transcranienne) est indiquée pour le traitement des épisodes dépressifs sévères avec symptômes psychotiques (ECT = tt le + efficace pour dépression sévère résistante)
- E. L'Activité physique fait partie du traitement de la dépression

R : D

TMS c'est avec ou sans sy psychotiques

ECT c'est plus efficace mais c'est pour dépression sans sy psychotiques.

Q24 : Patient de 25 ans borderline, TT ?

- A. Prise en charge psychothérapeutique pour le trouble en question
- B. ATD
- C. Traitement neuroleptique
- D. Stabilisateur de l'humeur afin de réguler ses émotions
- E. BZD pour la calmer

R : A

Les ATD ne marche pas bien dans le trouble BDL. Benzo contre indiqué.

Il est recommandé d'éviter les médicaments et préférer la psychothérapie.

Q25 : Parmi les troubles ci-dessous lequel n'est habituellement pas associé à des symptômes psychotiques ?

- A. Trouble anxieux type phobie sociale
- B. Trouble dépressif majeure avec épisode actuel sévère
- C. Trouble bipolaire
- D. SCZ
- E. Trouble de la personnalité BDL

R : A

Q26 : Femme de 24 ans se présente aux urgences avec son bébé de 3 mois. Elle craint de lui faire du mal car depuis qq semaines elle s'imagine qu'elle va le blesser avec un couteau. Elle n'arrive pas à chasser ces pensées qui la font terriblement souffrir. Elle aime son enfant et ne veut pas lui faire du mal. De quel symptôme s'agit-il le + vraisemblablement ?

- A. Hallucination
- B. Troubles du moi
- C. Dérégulation des émotions
- D. Délire de mort
- E. Pensées obsédantes

R : E

TT : Psychothérapie (TCC), ev. SSRI. On ne sépare pas la mère et l'enfant, seulement dans la situation exceptionnelle de dépression du post-partum avec délire de la mère qui veut tuer l'enfant, et en fait on les hospitalise ensemble.

Q27 : Laquelle des propositions suivantes est fausse concernant l'évolution du trouble bipolaire ?

- A. Survenue des épisodes thymiques est de moins en moins liée à des événements stressants
- B. Les modalités évolutives sont très variables
- C. L'évolution est habituellement marquée par une dégradation psychosociale
- D. La durée des phases de rémission tend à s'allonger
- E. La fréquence et la durée des phases dépressives tendent à augmenter avec l'âge

R : D

Naturellement et sans traitement, les phases de rémission tendent à se raccourcir.

Les épisodes sont de moins en moins associés à des événements, et se déclenchent spontanément.